

心理健康筛查综合报告

个人评估报告

姓名：ceshi 机构信息：校园心理筛查 (PsycheFlow) 报告日期：2026-08-31

△ 需要立即寻求帮助

我听到你正在承受很大的痛苦，你的感受很重要，你不是一个人。作为校园心理陪伴助手，我不能替代专业帮助——请立即联系你信任的老师、家长，或拨打青少年心理援助热线 12355，专业人员会陪着你一起面对。

触发信号：第9题 自杀意念/自伤想法 得分 3

青少年心理援助热线：12355（紧急危及生命请拨 120 / 110）

1. 测评工具介绍

PHQ-A 青少年抑郁筛查量表 (Patient Health Questionnaire for Adolescents) 基于国际通用的 PHQ-9 抑郁筛查九项量表，专为 11-17 岁青少年编制。量表采用李克特 4 级评分 (0=完全没有至 3=几乎每天)，评估过去两周内的抑郁症状频率与强度，总分 0-27，界值 ≥ 11 提示存在抑郁筛查阳性，建议由学校心理老师或专业人员进一步评估。PHQ-A 在全球校园普测中广泛使用，具有良好的信效度与青少年适配性，被纳入多个国家中小学心理健康筛查推荐工具清单。

SCARED 儿童焦虑相关情绪筛查量表 (Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders) 由美国匹兹堡大学 Birmaher 教授团队编制、中文版经国内学者修订，适用于 8-18 岁儿童青少年。量表包含 41 个条目，采用 0-2 三级评分，总分 0-82，官方推荐界值 ≥ 25 为阳性筛查，提示可能存在广泛性焦虑、社交恐惧、学校恐惧、分离焦虑或躯体化惊恐等焦虑相关症状。SCARED 是我国学校心理普测常用工具，具备良好的信度、效度及性别/年龄测量等值性。

2. 测评结果解读注意事项

为了更好地理解和使用本测评结果，请相关工作人员认真阅读以下注意事项：心理测验只在一定程度上反映了受测者在所测内容上的现状和特点，不能机械地将结果认定为最终结论，而要结合受测者的日常学习、家庭情况、同伴关系、健康状况、近期突发事件等多重因素、具体情况具体分析，绝不能只根据测验结果给被试贴标签或做定论。如果需要做定论的情况，由具备相关专业资质的人员来慎重裁定。

3. 测评人员信息

姓名	性别	年龄	编号	测评用时
ceshi	—	—	18e75f3b	—
学号	年级	测评工具编号	部门	测评工具
—	—	18e75f3b3d5841ffa14bad1347d62db5	校园心理筛查 (PsycheFlow)	PHQ-A + SCARED

4. 测评结果

需立即干预

Immediate Intervention

您的心理健康综合水平被评定为：需立即干预（结合量表作答、子维度剖析与危机信号综合判断）

量表名称	维度说明	原始得分	剖析结果
PHQ-A 青少年抑郁筛查量表	存在重度抑郁症状，建议立即转介专业评估。	27/27	重度
SCARED 儿童焦虑相关情绪筛查量表	总分 23/82，低于阳性界值 25，暂无明显焦虑倾向。	23/82	无明显症状

因子剖析	原始分	满分	等级	程度 (可视化)
认知/情感症状 PHQ-A	6	6	重度	
睡眠/精力/食欲 PHQ-A	9	9	重度	
自我价值/注意力 PHQ-A	6	6	重度	
精神运动/风险意念 PHQ-A	6	6	重度	
躯体反应 SCARED	0	16	无明显症状	
分离焦虑 SCARED	6	12	中度	
广泛性担忧 SCARED	8	24	轻度	
社交恐惧 SCARED	9	22	轻度	
学校恐惧/校园焦虑 SCARED	0	8	无明显症状	

5. 测评结果剖析

PHQ-A

重度	认知/情感症状	6 / 6 (100%)
维度说明：核心抑郁体验：做事提不起劲、情绪低落/沮丧		
兴趣感显著缺失，情绪持续沮丧，可能影响学习与社交功能，建议专业评估。		
重度	睡眠/精力/食欲	9 / 9 (100%)
维度说明：躯体与植物神经症状：入睡困难、疲劳无力、食欲变化		
睡眠/食欲紊乱明显，精力耗竭感强烈，可能影响日常功能，建议尽快就医评估。		

重度	自我价值/注意力	6 / 6 (100%)
维度说明：认知功能与自我评价：自我失败感、注意力难集中		
强烈的自我否定/挫败感，注意力难以维持，严重影响学习表现，需专业支持。		
重度	精神运动/风险意念	6 / 6 (100%)
维度说明：运动迟滞/激越与安全风险：语速动作慢或烦躁、自杀/自伤念头		
出现明显的精神运动异常或自我伤害/结束生命的想法，请立即联系学校心理老师、家长并拨打 12355 青少年心理援助热线，必要时拨打 120 或 110。		
SCARED		
无明显症状	躯体反应	0 / 16 (0%)
维度说明：焦虑在身体上的体现：出汗、发抖、心跳、晕倒、呕吐、心脏病感		
身体状态稳定，焦虑较少通过躯体化方式表达。		
中度	分离焦虑	6 / 12 (50%)
维度说明：与依恋对象分离相关的焦虑：父母分开、独处、被独自留下		
分离时有一定顾虑或偶尔做相关噩梦，可通过渐进式陪伴与固定仪式感适应。		
轻度	广泛性担忧	8 / 24 (33%)
维度说明：对健康、家庭、未来、自身表现等多领域的普遍担忧		
在多方面偶尔出现过虑，可尝试担忧外化书写与现实检验练习。		
轻度	社交恐惧	9 / 22 (40%)
维度说明：对公众场合与他人评价的焦虑：被注视、被取笑、当众发言		
在陌生或公众场合偶尔紧张，可通过社交暴露练习与角色扮演逐步适应。		
无明显症状	学校恐惧/校园焦虑	0 / 8 (0%)
维度说明：校园场景特有的焦虑：害怕上学、怕被欺负、怕哭出来失态		
对上学持积极或稳定的态度，校园生活无明显回避。		

6. 发展建议

发展建议

亲爱的同学，我们看到你正在承受着非常沉重的情绪负担，能够坦诚地面对并完成这份评估，本身就是一种勇气。你的感受是真实且重要的，请先给自己一些温柔与允许——这不是你的错，也不必独自硬扛。焦虑方面整体并不突出，但抑郁相关困扰已涉及认知、躯体、自我价值等多个层面，且已出现风险信号，我们非常担心你的安全。

家庭：让安全网先织起来

- 请家长务必高度重视本次评估结果，尽快（建议一周内）联系三甲医院精神心理科或儿童心理专科，由专业医生进行全面评估和干预，这是当前最优先、最关键的一步。
- 在家期间，请移除或妥善保管可能用于自伤的物品（如刀具、药品等），确保环境安全；尽量不要让孩子独处过长时间，尤其夜间需多留意。
- 建立每日固定的亲子沟通时间（如晚饭后15分钟），少问“为什么”，多说“我在听”，用陪伴代替追问，用接纳代替评判。

学校：寻求可信赖的支持

- 请家长主动与班主任或学校心理老师沟通评估结果，协商在校支持方案（如弹性作业、缩短在校时长、安排心理辅导等）。
- 若孩子愿意，可由心理老师或班主任指定一名“安全联系人”，在情绪崩溃时能及时找到成年人帮助；同时留意课间、体育课等相对松散时段的动向。

自我调节：先稳住当下，再谈改变

- 每天尝试“5-4-3-2-1”落地练习：说出你看到的5样东西、触摸到的4样东西、听到的3种声音、闻到的2种气味、尝到的1种味道，帮助自己从极端情绪中回到此刻。
- 不必强迫自己“开心起来”，只需规律作息——固定起床、用餐、入睡时间，哪怕只能做到部分，也是在为大脑恢复建立锚点。

请记住：重度抑郁不是性格缺陷，而是需要专业治疗的疾病。当前风险信号明确，切勿观望或等待“自己好转”。请家长和老师立即行动起来，用科学、坚定的方式守护孩子。你值得被帮助，也一定能够穿越这段黑暗。

本报告由 PsycheFlow 智能心理评估系统生成，报告生成模型：deepseek-v4-flash-0731。

非医疗器械，非替代专业诊疗，仅供校园心理筛查辅助参考。

报告生成时间：2026-08-31 15:43 报告编号：18e75f3b